

JOSE RICARDO FRANCHITO	
HD:	Parkinson / saliva intensa
MEDICO:	D ^{ro} Mario Jorge
MEDICAMENTOS:	Prolopa
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	IAH = 70.3 e/h
PA:	
OXIMETRIA:	

06/ P = 7.0
 12/ IAH = ~~2.1~~ 2.1
 21 Fuga = 41.2

12/ P = 8.5
 12/ fuga = 20.4
 21 IAH = 2.0

11/ P = 7.2
 02 IAH = 2.4
 22 m. de uso: 2h31.

08 P = 7.2
 04 IAH = 4.1
 22 m. de uso: 2h50'

22/10 Ajusto o CPAP
 22 troco filtro

06/03 P = 6.0 (mediana) 95%.: 7.8 IAH = 2.2
 20/23 p. auto 5-10 cmH₂O m. de uso = 5h50'
 p. min 5

10/05 P = 6.2 cmH₂O
 23 IAH = 1.1 e/h
 Fuga = 2.4 l/min

- Elevar a cabeceira da cama 10cm
 Deglutição difícil, durante a noite.
 - Tomar sol.

Relatório Drº Mário

07/08/23 P = 8.6
IAH = 1.3
M. de uso: 5h51'
bem adapt.

Jua

24/05/24 P = 5-10 cmH₂O → (med.) 6.3 cmH₂O percentil (7.4 cmH₂O)

IAH = 2.5 e/ev
M. de uso: 1h46'

Jua

P = 5-8 cmH₂O
IAH = 4.5 e/ev
M. de uso: 3h30'

24/06/24 { P = 8 cmH₂O
IAH = 2.6 e/ev
M. de uso: 5h30'

24/06/25 Falei com a filha Raquel, tentei falar com o Srº Ricardo, mas sem sucesso.
Ele não está utilizando há 2m. o CPAP. Jua.

DR ALBERTO REMESAR

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: José Ricardo Franchito
EXAME nº: 4755
SOLICITADO POR: Dr. Mário Silva Jorge
DATA: 11/11/2020
IDADE: 67 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h39min e concluído às 05h28min. A latência para o sono foi de 10 minutos e a latência para o estágio REM, de 142 minutos. O tempo total de sono foi de 320 minutos (05h20min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 68,7%. A distribuição do sono registrado mostrou 33,8% de estágio 1, 41,4% de estágio 2, 13,3% de estágio 3 e 11,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 135 minutos em vigília, ocorreram 230 microdespertares (Índice: 43,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 8,1/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 70,3/hora, sendo 33,9 apneia/hora e 36,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 70,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a média de 92% e a mínima de 79%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (70,3/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (70,3/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, que se acentuaram durante o estágio REM, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 72 bpm.

O ronco foi contínuo e médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 10 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (142 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 68,7%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (Índice: 43,1/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (33,8%; normal: 8-10%) e 3 (13,3%; normal: 10-12%), e a redução dos estágios 2 (41,4%; normal: 45-55%) e REM (11,7%; normal: 20%).

Aumento leve do índice de movimentos periódicos de membros (Índice: 8,1/hora; índice leve: 5 a 25/hora). Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 15 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

CPAP

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
RM 68730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 46.730

clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DRa. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP: 62.858

CRM-SP: 69.730

NOME: José Ricardo Franchito
EXAME nº: 5211
SOLICITADO POR: Dr. Mário Silva Jorge
DATA: 06/09/2022
IDADE: 69 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h48min e concluído às 06h35min. A latência para o sono foi de 2 minutos e a latência para o estágio REM, de 103 minutos. O tempo total de sono foi de 432,5 minutos (07h12min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 94,1%. A distribuição do sono registrado mostrou 10,2% de estágio 1, 65,3% de estágio 2, 7,3% de estágio 3 e 17,2% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 24,5 minutos em vigília, ocorreram 104 microdespertares (índice: 14,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 16,5/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 53,1/hora, sendo 33 apneia/hora e 20,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 53,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 94% e a mínima de 77%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono

TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (53,1/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (53,1/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina e arritmia cardíaca (extrassístoles). As frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 72 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.
Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente dormiu rapidamente (latência para o sono: 2 min.; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (103 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (94,1%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (14,4/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento da porcentagem do estágio 2 (65,3%; normal: 45-55%) e a redução dos estágios 3 (7,3%; normal: 10-12%) e REM (17,2%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 1 (10,2%; normal: 8-10%) permaneceu nos limites da normalidade.

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (16,5/hora; índice normal até 15/hora).

Escala de Sonolência de Epworth: 17 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730